

Douleurs thoraciques

Anamnèse

1. Douleurs thoraciques
 - a. Localisation
 - b. Irradiation
 - c. Intensité
 - d. Qualité
 - e. Facteurs aggravants (respiration-dépendant)
 - f. Facteurs soulageants (position dépendant)
 - g. Chronologie
 - i. Depuis quand
 - ii. Évolution
 - iii. Condition de survenues (trauma, sport, ...)
2. Dyspnée
 - a. Condition de survenue
 - b. Classification (périmètre de marche, nb étage etc)
 - c. Chronologie
3. Symptômes associés
 - a. Toux
 - i. Depuis quand
 - ii. Fréquence
 - iii. Qualité (sèche, grasse)
 - iv. Expectoration
 1. Couleur
 2. Sang
 - b. Hémoptysie
 - c. Douleurs ou œdèmes des membres inférieurs (EP)
 - d. Orthopnée – dyspnée paroxystique nocturne
 - e. Nycturie
 - f. Palpitation**
 - g. Fièvre**
4. Facteurs de risques
 - a. Tabagisme
 - b. Voyages récents (> 6h, pays?)
 - c. Chirurgie, immobilisation récente – cancer
 - d. Médicaments, contraceptions – grossesse (EP)
 - e. ATCD EP, thrombose, phlébite,
 - f. ATCD angine de poitrine
 - g. ATCD AVC
5. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie : **diabète, hypercholestérolémie, HTA**
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments
 - e. Allergies
6. ATCD familiaux

Signes d'alarme

- Sudations profuses
- TA < 90/60 mmHg
- Pouls > 120/min
- Tachypnée > 30/min
- Cyanose
- Arythmie nouvelle
- Signes cliniques de TVP (douleur, œdème d'un MI)
- Déficit neurologique
- Disparition des pouls aux MI
- Asymétrie de TA systolique aux MS (>11 mmHg)
- Déviation trachéale
- Turgescence jugulaire

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Recoloration capillaire
 - d. Thorax et mouvements
 - e. **Oedèmes des MI** (godet)
 - f. **Turgescence jugulaire (Reflux hépato-jugulaire (> 10s))**
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspide
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Antérieure
 - ii. Postérieure : 4 plages en comparant
 - iii. Latérales : 2 plages

Examen complémentaire :

- ECG
- Rx thorax (év CT, US)
- Laboratoire
 - FSC
 - Troponine si suspicion SCA
 - D-dimère si proba EP faible ou moyenne

DD

- *Cardiaque*
 - **SCA**
 - *Angor – angor instable* : douleur constrictive ne durant que qq minutes et répondant év. aux dérivés nitrés
 - *Infarctus du myocarde* : douleurs constrictive irradiants dans le bras et la mâchoire non soulagée par les dérivés nitrés, patient souvent figé avec des sudations profuses, signes d'IC, troponine positive
 - **Dissection aortique** : douleur transfixiante interscapulaire avec début brutal, en coup de poignard avec év. souffle diastolique d'insuffisance aortique, asymétrie tensionnelle aux 2 bras > 20 mmHg, abolition des pouls périphériques
 - **Tamponnade** : bruit lointain, hypotension
 - **Péricardite** : douleur peut être épisodique, d'apparition progressive, rétro-sternale – latérale gauche avec irradiation vers le cou – épaule gauche, soulagée par la position assise et la flexion du tronc, frottement péricardique
 - **Valvulopathie**
 - **Myocardite s**
- *Pulmonaire*
 - **Embolie pulmonaire** : douleur pleurale respiro-dépendante avec début brutal, dyspnée, polypnée, toux, hémoptysie, tachychardie et hypotension, ! peut entrainer une pleurésie qui peut faire une doul. reproductible à la palpation. Faire D-dimère seulement si probabilité faible ou intermédiaire, faire directement CT-scan si probabilité élevée
 - *Pathologie pleurale*
 - **Pneumothorax** : douleur aiguë respiro-dépendante, unilatéral, toux, homme, fume, fin, tympanisme, diminution murmure vésicale
 - **Pneumonie - bronchite** : fièvre, toux
 - **Pneumomédiastin**
- *Digestif*
 - *Œsophage*
 - **RGO** : douleur retrosternale, de type brûlure, soulagée par la nourriture, aggravée par le décubitus dorsal après les repas
 - **Spasme de l'œsophage** : région sternale, profonde, douleur mimant l'angor, ne dure que 2-3 min, associée aux liquides froids, ! peut être soulagée par la nitroglycérine !
 - **Déchirure** : brutal
 - **Estomac : ulcère, gastrite** : brûlure épigastrique, profonde, soulagement de la douleur après le repas (lait) et par les anti-acides
 - **Pancréas, foie, VB : cholécystite** : profonde, hypochondre, survient ap. repas

- *Autre*

- *Atteinte neuro* : douleur en ceinture, hémi-ceinture +/- trouble de la sensibilité
- *Thyroïdite* : douleur persistante, région du cou, aggravée en avalant, palpation de la thyroïde douloureuse → faire VS et TSH
- *Atteinte pariétale* : douleur de longue durée superficielles fluctuantes, douleur mécanique (exacerbées par une position ou un mouvement), reproductible à la palpation
 - *Syndrome chondrocostal* : cartilages chondrocostaux hauts ou costosternaux, pas de tuméfaction
 - *Syndrome de Tietze* : tuméfaction de la jonction costosternale, sternoclaviculaire ou chondrocostal (2^{ème} – 3^{ème} côte) *rare*
 - *Syndrome pectobrachial* : développé couché, travail sur un ordinateur, manœuvre du coq →
 - *Syndrome sternal* : douleur sur le sternum avec souvent une extension latérale de la douleur
 - *Syndrome xiphoïdien* : douleurs sur l'apophyse xiphoïdienne
 - *Douleurs costales basses* : hooking maneuver →
- *Cutané (zona)*
- *Douleur thoracique psychogène* : punctiforme, brève, augmente en inspiration, calmée couché



SE RENDRE À L'HÔPITAL (EP, infarctus, pneumothorax)

Les pièges : il peut s'agir d'un syndrome coronarien aigu, même si le patient présente :

- Une douleur épigastrique
- Une douleur dorsale
- Une brûlure thoracique
- Une irradiation vers l'épaule droite
- Une absence de douleur (surtout s'il est diabétique)
- Un ECG normal
- Une absence de soulagement par un dérivé nitré